

고객의 안정된 미래를 위한 재무안전망 구축

『컨설팅 특급보고서』

[노부모 부양 맞벌이 여성]
가족 건강과 재정 모두 지키는 균형 설계

본 자료는 AI를 활용하여 생성되었으며, 검증과정을 거쳤으나 참고용으로 사용하시기 바라며, 실무적용 시에는 분야별 전문가와 협의 후 사용하시기 바랍니다.

컨설턴트 여러분, 안녕하세요. 오늘 우리가 만날 고객은 이 시대의 진정한 '슈퍼우먼'입니다. 직장에서는 유능한 전문가, 가정에서는 자상한 어머니이자 아내, 그리고 연로하신 부모님께서는 든든한 버팀목이 되어주는 분들입니다. 하지만 이 모든 역할을 감당하는 그녀의 어깨는 보이지 않는 책임감의 무게로 위태롭습니다.

본 특급보고서는 바로 이 위대한 여성들의 가장 치명적인 리스크, 즉 '자신이 아파서 쓰러지는 상황'을 방지하기 위해 제작되었습니다. 우리는 '희생'이 아닌 '지혜'로운 사랑을 제안해야 합니다. 본인의 소득보장을 최우선으로 강화하고, 부모님의 간병 리스크는 보험으로 분산시키며, 가족 전체의 보장을 통합적으로 재설계하는 '3세대 균형 설계'를 통해, 고객이 자신을 먼저 지킴으로써 가족 전체를 가장 안전하게 지킬 수 있는 길을 제시할 것입니다.

이 솔루션은 단순한 보험 제안을 넘어, 고객의 삶의 무게를 덜어주고 미래에 대한 통제력을 되찾아주는 가장 확실한 재무적 처방전이 될 것입니다.

I. 고객 프로파일 및 재무상황 분석 (Client Discovery)

이 시대의 수많은 사람들은 비슷한 고민을 안고 있습니다. 고객의 삶을 깊이 공감하는 것이 컨설팅의 첫걸음입니다.

1. 고객 프로파일

구분	내용
성명	박선영 (가명)
연령	만 45세
직업	IT 기업 마케팅팀 팀장
가족 관계	- 배우자(만 46세, 회사원) - 자녀 2명(중학생, 초등학생) - 친정어머니(만 72세) - 3년 전 부친상, 현재 홀로 거주 중

3 I. 고객 프로파일 및 재무상황 분석 (Client Discovery) (계속)

구분	내용
라이프스타일	대표적인 '샌드위치 세대'로, 회사와 가정, 노부모 부양의 다중 역할을 수행. 주중에는 격무에 시달리고, 주말에는 자녀 교육과 친정어머니 병원 방문 등으로 쉴 틈이 없음. 최근 친정어머니가 초기 치매 진단(CDR 척도 1) 및 퇴행성 관절염으로 거동이 불편해지면서 간병에 대한 부담이 현실화됨.
핵심 고민	맞벌이 소득의 상당 부분이 자녀 교육비와 어머니 병원비/생활비로 지출되어, 정작 부부의 노후 준비는 시작도 못 하고 있음. '만약 내가 아프거나 다쳐서 일을 못 하게 되면 우리 집은 어떻게 될까?'라는 극심한 불안감에 시달림. 어머니의 간병비가 앞으로 얼마나 더 늘어날지, 언제까지 감당할 수 있을지 막막함. 가족 각자가 가입한 보험은 많아 보이지만, 정작 필요한 보장이 무엇인지, 중복되거나 부족한 부분은 없는지 알지 못해 답답함.

2. 재무 현황 분석

구분	내용	비고
월 평균 부부 합산 수입	1,200만 원	본인 700만 원, 배우자 500만 원
월 평균 지출	1,000만 원	- 고정비(대출, 공과금): 300만 원 - 생활비: 250만 원 - 자녀 교육비: 250만 원 - 친정어머니 지원: 100만 원 - 보험료: 100만 원
월 잉여 자금	200만 원	대부분 예/적금으로 저축 중
주요 자산	- 거주 아파트 (시세 12억 원, 주택담보대출 4억 원) - 금융자산 (예/적금 1.5억 원, 펀드 5천만 원)	
주요 부채	주택담보대출 4억 원	

3. 인생 목표 및 리스크 분석

- 단기 목표: 자녀들의 안정적인 학업 지원, 친정어머니의 건강 유지
- 중기 목표: 15년 후 부부 동반 은퇴 및 경제적 독립
- 장기 목표: 자녀에게 경제적 부담을 주지 않는 노후 생활
- 핵심 리스크:
 - 본인의 소득 상실 리스크: 가계 소득의 약 60%를 차지하는(부부합산 1,200만원 중 700만원) 본인이 질병/상해로 경제 활동을 중단할 경우, 즉시 적자로 전환되며 모든 재무 계획이 붕괴됨.
 - 부모의 간병 리스크: 어머니의 치매가 악화되어 장기요양상태에 진입할 경우, 월 200~300만 원의 간병비 발생으로 부부의 노후자금을 잠식할 위험. (사설 간병인, 비급여 항목 포함 시 참고치이며, 지역별·등급별로 차이가 있을 수 있음)
 - 가족 재무 시스템 부재: 가족 단위의 통합적 재무 목표나 리스크 관리 계획 없이, 각자의 판단에 따라 지출과 저축, 보험 가입이 이루어져 비효율 발생.

[전문가 의견] 박선영 팀장님의 가장 큰 문제는 재무적 '안전판'이 자기 자신이라는 점입니다. 그녀가 건강하게 소득을 창출해야만 이 가정이 유지되는 아슬아슬한 구조입니다. 우리의 역할은 이 '외줄타기' 같은 재무 구조에 튼튼한 '그물망'을 설치하는 것입니다. 첫째, 그녀 자신이 쓰러져도 소득이 유지되는 시스템을 만들고, 둘째, 어머니 간병이라는 거대한 구멍으로 돈이 새어 나가지 않도록 방어해야 합니다.

6 II. 제안서 요약 (Executive Summary)

구분	내용
핵심 재무과제	가계의 핵심 소득원인 '본인'의 보장 공백 및 '부모 간병' 리스크의 재정적 전이 본인 유고 시 발생하는 월 700만 원의 소득 상실에 대한 대비책이 전무하며, 이는 가정 경제 붕괴의 직접적인 원인이 됨. 어머니의 간병 비용을 현재의 소득과 저축으로 충당하려는 계획은 '밑 빠진 독에 물 붓기'와 같으며, 결국 자녀 교육과 부부 노후 자금을 희생시키는 결과를 초래.
솔루션 요약	'나'를 지키고 '부모'를 돌보는 '3세대 통합 재무 방어 시스템' 구축 본인 소득보장 강화: 3대 질병 진단비 및 소득보상보험을 최우선으로 확보하여, 가계 소득 급감을 상당 부분 완화하도록 설계. 부모 간병 리스크 분산: 고객(딸)이 계약자가 되어 부모님의 간병/치매 보험에 가입, 월 보험료 지출을 통해 미래의 예측 불가능한 간병비를 '고정비용'으로 통제. 가족 보장 리모델링: 3세대 가족 전체의 보험을 분석하여 중복 보장을 줄이고, 절감된 비용으로 핵심 보장을 강화하는 '가족 단위 포트폴리오 최적화' 실행.
기대 변화	재무적 변화: 부모 간병비 리스크가 자녀 세대의 재정을 잠식하는 고리를 차단. 본인의 소득 상실 위험에 대한 강력한 방어막 구축으로 재무적 안정성 확보. 심리적 변화: 건강 리스크에 대한 심리적 부담을 상당부분 완화 효도와 나의 삶, 자녀의 미래 사이에서 균형을 찾고, 미래에 대한 자신감과 통제력 회복.

7 III. 재무·보장자산 정밀 진단 (In-depth Diagnosis)

1. 금융 포트폴리오 분석

- 부부 합산 소득은 높으나, 지출 통제가 이루어지지 않고 명확한 재무 목표가 없어 잉여 자금 활용 효율이 낮습니다.
- 월 100만 원의 어머니 지원금은 향후 간병 상황에 따라 더 늘어날 가능성이 높아, 현재의 저축 시스템을 위협하는 가장 큰 변수입니다.

2. 기가입 보험 평가 (가족 통합 분석)

구분	가입 보험	월 보험료	잘된 점 (유지)	부족한 점 (보완/조정)
본인(박선영)	- 종신보험 (사망 1억) - 실손보험 (2세대) - 암보험 (진단비 3천)	40만 원	기본적인 사망, 실손, 암 보장을 갖추.	- 뇌/심장 진단비 전무 - 소득 상실 대비 보장 전무. - 암 진단비가 소득 대비 매우 부족.
배우자	- 종신보험 (사망 1.5억) - 실손보험 (2세대) - 종합건강보험	35만 원	가족의 생활 보장을 위한 사망보험금과 종합 보장 구성이 양호함.	상대적으로 소득이 적어 본인보다 보장 우선순위는 낮으나, 2대 질환 보장 등 점검 필요.
자녀 (2명)	- 어린이보험 2건 - 치아보험	15만 원	성인보다 넓은 범위의 보장과 납입면제 등 좋은 조건으로 가입됨.	일부 불필요한 특약이나 중복 가입 여부 점검 필요.
친정어머니	- 실손보험 (유병자용) - 건강보험 (사망 시 1천만 원 지급)	10만 원	고령임에도 실손보험을 보유하고 있어 병원비 부담을 일부 덜 수 있음.	- 간병/치매 대비 보장 전무. - 진단비, 수술비 등 보장 전무.

8 III. 재무·보장자산 정밀 진단 (In-depth Diagnosis) (계속)

3. 보장 갭(Gap) 진단

보장 항목	대상	필요 보장액	현재 준비액	보장 갭 (부족액)
3대 질병 진단비	본인	1억 5,000만 원	3,000만 원	- 1억 2,000만 원

보장 항목	대상	필요 보장액	현재 준비액	보장 갭 (부족액)
소득보상 (월)	본인	500만 원	0 원	- 500만 원
간병비 (월)	어머니	200만 원	0 원	- 200만 원
치매 진단/생활비	어머니	5,000만 원	0 원	- 5,000만 원

9 III. 재무·보장자산 정밀 진단 (In-depth Diagnosis) (계속)

위험도 vs 보장도 매트릭스

축: 위험도 HIGH / 보장도 HIGH

소득상실(보장: 0%) | 부모간병(보장: 0%) | 자녀교육(보장: 50%) | 사망보장(보장: 100%)

범례: = 긴급 대응 필요 / = 보완 필요 / = 적정

[전문가 의견] 진단 결과는 명확합니다. 가족 재무 시스템의 '엔진'인 박선영 팀장님 본인에 대한 보호 장치가 가장 허술하고, 가장 큰 지출이 예상되는 '브레이크' 즉, 어머니의 간병 문제에는 아무런 대비가 되어 있지 않습니다. 불필요한 보험료를 줄여, 이 두 가지 핵심적인 '갭'을 메우는 것이 이번 컨설팅의 성패를 좌우합니다.

1. 설계 방향 및 원칙

- 원칙 1 (자기보호 우선): 가족을 지키기 위해, 가장 먼저 자신부터 지킨다. 본인의 소득보장 체계를 완벽하게 구축한다.
- 원칙 2 (리스크의 외주화): 감당할 수 없는 부모님의 간병 리스크는 직접 떠안지 말고, 보험이라는 금융 시스템을 통해 '외주화' 하여 재정적 안정을 꾀한다.
- 원칙 3 (효율성 극대화): 가족 전체의 보험을 하나의 포트폴리오로 보고 중복을 제거하며, 절감된 재원으로 핵심 보장을 강화하여 '최소 비용, 최대 효과'를 추구한다.

2. 포트폴리오 리모델링 전략

어머니의 보험 가입 가능 여부라는 핵심 변수에 따라, 두 가지 시나리오를 모두 준비해야 합니다. 각 플랜은 상호보완적이며, 어떤 상황에서도 고객의 재무 목표를 달성할 수 있도록 설계되었습니다.

11 IV. 맞춤형 솔루션 제안 (Customized Solution) (계속)

[Plan A] 리스크 완전 이전(外注化) 전략 (어머니 보험 가입 가능 시)

1) 본인(박선영) 소득보장 강화

[솔루션] 기존 암보험 3천만 원에, 암/뇌/심장 진단비를 각각 7천만 원씩 보강하여 3대 질병 진단 시 총 1억 원의 비상 자금을 확보. 추가로, 약관상 지급사유(예: 근로불능 또는 장애지급률 기준 충족) 발생 시 매월 200만 원씩 10년간 지급하는 보험을 신규 가입.¹

[기대효과] 암 진단 시 1년 치 연봉에 가까운 금액으로 치료에 전념하고, 소득 활동이 불가능해져도 매월 고정적인 수입으로 최소한의 가계 지출을 감당할 수 있음.

¹ 소득보장보험 지급 기준 상세: 지급사유, 대기기간(예: 30/60/90일), 재심사 요건 등은 상품별로 상이합니다. 특히 직업분류(직장인/자영업 등)에 따라 인수, 보험료, 지급 기준이 달라지므로 계약 전 반드시 확인해야 합니다.

2) 어머니 간병/치매 보험 준비

[솔루션] 계약자와 수익자를 '딸(박선영)', 피보험자를 '어머니'로 설정하여, 공적 장기요양등급 판정 또는 중증치매(CDR 3) 등 약관에서 정한 요건을 충족할 때 약정된 보험금을 지급하는 플랜에 가입.

[핵심 검토사항: 지급 기준 및 세무 이슈] 지급 기준: ①대기기간/보장개시일(계약 후 N개월, 상품별 상이)과 ②상태 지속기간 요건(예: 90일 이상 지속 시 지급)은 서로 다른 요건이므로 각각 확인이 필수적입니다. 세무 이슈: 계약자와 수익자가 동일(딸)하면 원칙적으로 증여의제에 해당하지 않으나, 보험료 자금 출처 등 실질과세 원칙에 따라 증여 이슈가 발생할 수 있으므로 세무 전문가와 상담이 필요합니다. (예: 보험료가 모친 계좌에서 자동이체되거나, 딸 계좌라도 모친이 현금으로 상환한 내역이 반복될 경우 자금출처 추적 시 증여로 판단될 수 있음)

[실무 현실 체크] 인수 제약: 72세 고연령 및 초기 치매 진단 이력으로 인해 보험사 인수 심사 시 가입이 거절되거나, 부담보 설정, 또는 매우 높은 할증이 적용될 가능성이 높습니다. 현실적 보험료: 가입이 가능하다 해도, 보장 내용에 따라 월 25~40만 원 이상의 높은 보험료가 책정될 수 있습니다. 이는 반드시 고객과 협의하여 예산 내에서 조정해야 합니다.

3) 가족 보험 통합 리모델링

[솔루션] 자녀들의 보험에서 중복된 입원일당 등을 일부 조정하여 월 5만 원의 보험료를 절감하고, 이 재원을 신규 보장 강화에 활용합니다.

※ 기존 계약 조정 시 유의사항: 기존 계약의 해지·감액은 해지환급금 손실, 신규 가입 거절/할증 등 불이익이 발생할 수 있습니다. 반드시 비교설계서로 유·불리를 확인한 뒤 진행합니다.

[Plan B] 하이브리드 재무 방어 전략 (어머니 보험 가입 불가 시)

1) 전략 개념

보험 가입이 불가할 경우, 리스크를 방치하는 것이 아니라 '본인 보장 극대화'와 '자체 간병 자금 형성'이라는 두 가지 축으로 직접적인 재무 방어 벽을 구축하는 전략으로 전환합니다. (자세한 상담 화법은 VII. 컨설팅 시나리오의 '상담주제 3'에서 별도 제시)

2) 솔루션 실행

- ① 본인 보장 극대화: Plan A의 어머니 보험료 예산(월 25~40만 원)까지 모두 팀장님 본인의 소득보장(DI) 및 3대 질병 진단비 강화에 추가 투자합니다. 이는 가계의 핵심 소득원을 철벽 방어하여, 어떤 위기에도 간병 자금을 마련할 수 있는 기초 체력을 확보하는 최우선 조치입니다.
- ② 간병 자금 시스템 구축: '어머니 간병 준비 전용 CMA' 또는 '단기 채권형 펀드' 등 별도 계좌를 개설하고, 매월 고정된 금액(예: 월 20만 원)을 강제 자동이체하는 시스템을 만듭니다. 이는 단순 저축이 아닌, 명확한 목표를 가진 '재무 프로젝트'로 관리합니다.

3) 기대 효과

월 20만 원씩 적립 시, 5년 후 약 1,200만 원, 10년 후 약 2,400만 원(세전, 수익률 미고려)의 '1차 비상 자금'이 확보됩니다. 이 자금은 전체 간병비를 해결하는 것이 아니라, 위기 발생 시 가장 중요한 초기 1~2년을 버틸 '시간'과 '선택권'을 확보해주는 핵심적인 역할을 합니다.

3. 최종 제안 설계안 (요약표 - Plan A 기준)

구분	Before	After	월 보험료 변동
본인 보장	- 암 3천 - 뇌/심장 0 - 소득보상 0	- 3대 진단비 각 1억 - 월 소득보상 200만 원	+ 12~18만 원
어머니 보장	- 간병/치매 0	- 월 간병비 100만 원 - 중증치매 진단비 3천만 원	+ 25~40만 원
자녀 보장	- 일부 중복 특약 존재	- 핵심 보장 위주로 슬림화	- 5만 원
월 보험료 합계	100만 원	132 ~ 153만 원	+ 32~53만 원

* 보험료는 피보험자의 연령, 건강상태 및 실제 심사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ Plan B 실행 시, 총 보험료는 본인 보장 강화 수준에 따라 결정되며(107~113만원), 별도 간병 자금(월 20만원) 적립이 추가됩니다.

💰 월 현금흐름 시뮬레이션 (위기 상황 발생 시)

BEFORE (대비 없을 시)

수입 (배우자만): 500만 원

지출 (기존 + 간병비): 1,000만 원 + 250만 원

월간 적자: -750만 원 🚨

연간 손실: 9,000만 원

AFTER (Plan A 적용 시)

수입 (배우자+보험금): 800만 원

지출 (기존 + 간병비): 1,250만 원

적자 대폭 감소: -450만 원 ✅

재무 붕괴 방어

AFTER (Plan B 적용 시)

수입 (배우자+강화된 보험): 750만 원

지출 (기존 + 간병비): 1,250만 원

적자 관리 가능: -500만 원 

별도 자금으로 부담 완화

4. 제안 이유 (Rationale)

월 30~50만 원대의 추가 투자로, 예측 불가능했던 두 가지 거대 리스크, 즉 '나의 소득 단절'과 '부모의 간병비'를 통제 가능한 범위로 가져올 수 있습니다. 이는 단순 비용이 아닌, 가족의 미래를 지키는 가장 확실한 투자입니다. 보험 가입이 가능한 Plan A는 리스크를 완벽히 이전하는 최상의 선택이며, 차선택인 Plan B 역시 리스크를 방치하는 대신 적극적으로 관리하여 재무적 충격을 최소화하는 가장 현실적인 대안입니다.

※ 보험료 부담 점검: 월 총 보험료 / 월 가처분소득 $\leq$ 10~12%인지 간단 점검하여 과부하 가입을 방지합니다(초과 시 중복담보 정리·보장액/기간 미세조정).

1. Before & After 시뮬레이션

[상황 가정: 2년 후 어머니가 중증치매(CDR 3) 판정을 받고, 3년 후 본인이 유방암 진단을 받는 경우]

구분	Before (솔루션 실행 전)	After (솔루션 실행 후)	비고
어머니 간병	월 250만 원 간병비 전액 부담. 저축 중단 및 마이너스 가계 시작.	간병보험에서 월 100만 원, 치매진단금 3,000만 원 수령. 실제 부담 월 150만 원으로 감소.	*보험 약관 충족 및 등급 판정 시
본인 암 치료	암 진단비 3천만 원으로 치료. 예금 인출 및 소득 중단으로 가계 파탄 직전.	암 진단비 1억 원 수령. 치료비/생활비 걱정 없이 회복에 전념.	*진단 및 약관 기준 충족 시
재무적 결과	약 8,000만 원 이상 자산 감소 및 부채 발생 가능성. 노후 준비 전면 중단.	보험금으로 핵심 위기 방어. 자산 감소 최소화 및 재무 계획 유지.	

2. 가족·심리적 변화

- "나 하나만 바라보는 가족들을 어찌나"라는 죄책감과 압박감에서 벗어나, 시스템이 나를 지켜준다는 심리적 안정감을 얻게 됩니다.
- 부모님께서는 죄송한 마음 없이 안정적인 간병 서비스를 제공할 재원을 마련하고, 자녀에게는 부양의 짐을 넘기지 않는 당당한 부모가 될 수 있습니다. 이는 돈으로 환산할 수 없는 '삶의 통제력'을 회복하는 과정입니다.

1. 전문가 최종 의견

"팀장님, 지난 수년간 가족을 위해 헌신하며 정말 애쓰셨습니다. 하지만 어머니를 돌보는 것도, 자녀를 키우시는 것도, 모두 팀장님이 건강해야 가능한 일입니다. 가족을 사랑하는 가장 완벽한 방법은, 가장 먼저 팀장님 자신을 지키는 것입니다. 팀장님이 아프시면, 간병비는 두 배로 들고 소득은 절반으로 줄어듭니다. 반대로 팀장님의 건강과 소득을 지키는 것은, 이 가정의 재정을 지키는 가장 효과적인 레버리지입니다. 월 30~50만 원의 투자는 사라지는 비용이 아니라, 팀장님과 가족의 미래를 지키는 가장 든든한 방패가 될 것입니다. 이제 그 무거운 짐을 조금 내려놓고, 지혜로운 시스템에 기댈 시간입니다."

2. 실행 플랜 (Action Plan)

- 1단계 (가족 보장 분석 및 동의): 가족 구성원의 기가입 보험 증권을 모두 준비하여 통합 분석을 진행합니다. 타인(부모) 사망을 담보하는 계약 등은 피보험자 서면동의가 필수(상법 제731조) 임을 안내하고 준비합니다.
- 2단계 (솔루션 확정): 제언 드린 Plan A/B 전략 중 최종안을 확정하고 세부 보장 내역을 조정합니다.
- 3단계 (계약 실행): 기존 보험 조정 및 신규 보험 가입(또는 간병 자금 계좌 개설) 절차를 원스톱으로 진행합니다.
- 4단계 (정기 리뷰): 향후 1년 주기로 가족의 재무 상황과 보장 내용을 정기적으로 점검하고 최적화할 것을 약속드립니다.

3. 고객 유형별 맞춤 설계 가이드

A. 소득 구간별 설계 방향

- [월소득 500만원 이하 가구] 본인 보장을 최우선으로 하고(Plan B와 유사), 어머니 간병은 보험보다 적립형 대응에 집중. 월 총 부담 15만원 이내로 제한.
- [월소득 800만원 이상 가구] Plan A의 풀 보장 설계를 적극 추진. 보장 자산 외에 투자 포트폴리오 연계 및 세무 최적화까지 통합 컨설팅 제언.
- [자영업자 가구] 소득 변동성을 고려하여 보험료 납입 유예/중지 기능이 있는 상품을 우선 검토. 사업장 리스크(화재, 배상책임)까지 통합하여 점검.

B. 가족 구조별 변형 전략

- [외동딸인 경우] 모든 부담을 혼자 져야 하므로, 본인 소득보장 비중을 일반적인 경우보다 1.5배 이상으로 강화할 것을 권장.
- [형제자매가 있는 경우] 간병비 부담 원칙(역할/금액)을 사전에 명확히 하도록 조언. 보험 계약 시 수익자 지정 또는 부담 계약서를 통해 향후 분쟁 소지를 예방.

4. 평생 파트너 약속

단순히 보험을 판매하는 사람이 아니라, 팀장님 가정의 모든 재무적 고민을 함께 나누고 해결하는 '금융 주치의'가 되어 드리겠습니다. 계약이 끝이 아닌, 든든한 관계의 시작입니다.

21 VI-1. 현장 의사결정 플로우 (Step-by-Step)

현장 의사결정 플로우 (클릭하여 확인하세요.)

목적: 상담을 "발견 → 설계 → 검증 → 실행 → 사후관리"로 일관되게 운영하기 위한 표준 절차.

1

리스크 확인 & 공감 래핑 (Discovery)

- 핵심 질문 3가지:
- "본인 한 달 소득이 멈추면 가계는 얼마나 버티나요?"
- "어머니 간병비가 월 200~300만 원 발생하면 어느 항목을 줄이실 건가요?"
- "지금 보험 구조에 중복/공백은 없나요?"
- 증상 요약 한 줄: "소득방어 0% + 간병비 무한변동 = 현금흐름 붕괴 위험"

[실무 체크]

- 상담 전: 어머니의 정확한 생년월일, 건강상태, 복용 약물, 병원 이력 등을 반드시 사전 확인합니다.

22 VI-1. 현장 의사결정 플로우 (Step-by-Step) (계속)

2

증권 수집 & 현재 상태 가시화 (Intake)

- 모든 가족(본인/배우자/자녀/모친) 기가입 증권·특약·보험료·갱신 주기 수집
- “보장 갭 표”로 금액/월지급/기간을 수치화(소득보상·3대진단·LTC)

[실무 체크]

- 상담 중: 고객이 생각하는 월 여유자금과 실제 필요한 보장 수준의 갭을 확인하고, 배우자의 보장 필요성에 대한 동의를 확보합니다.

23 VI-1. 현장 의사결정 플로우 (Step-by-Step) (계속)

3

핵심 설계안 초안 (Design Draft)

- 원칙: 자기보호 우선(DI + 3대진단) → 부모 간병(LTC) → 중복 정리
- 목표안(예시): 암·뇌·심장 각 1억, DI 월 200만/10년, LTC 월 100만 + 치매진단금
- 월보험료 총량: “월 가처분소득의 7~10% 이내” 1차 걱정심

[실무 체크]

- 상담 중: 형제자매가 있을 경우 역할 분담에 대한 의사를 미리 타진하고, 세무 리스크에 대한 고객의 이해도를 점검합니다.

24 VI-1. 현장 의사결정 플로우 (Step-by-Step) (계속)

4

리스크 검증 (Compliance & Underwriting)

- 언더라이팅: 연령/기왕력/직업등급/대기·지급 트리거/재심사 체크
- 세무/법규: 계약자=수익자 동일 구조, 상증세법 §34, 상법 §731 확인
- 문구 정밀화: “약관 요건 충족 시 지급(등급·CDR·지속기간·개시일)”

[실무 체크]

- 상담 후: 심사 진행 상황을 주기적으로 업데이트하고, 가입 거절 시 Plan B 시나리오를 즉시 제시하며, 가입 후 3개월 뒤 부담 정도를 재점검할 것을 약속합니다.

25 VII. 컨설팅 시나리오 (Consulting Scenarios)

▶ 상담주제 1: 나를 지키는 것이 최고의 효도입니다

리스크 진단 (As-Is 파악):

고객이 자신보다 가족을 우선시하며 정작 본인의 보장에는 소홀한 현실을 공감하며 짚어줍니다. "팀장님이 이 가정의 기둥인데, 기둥이 흔들리면 집 전체가 무너집니다."

전략 제안 (To-Be 플랜):

본인 보장 강화를 '이기적인 선택'이 아닌 '가족을 위한 가장 책임감 있는 행동'으로 재정의합니다. 소득 상실 시의 구체적인 재무 충격을 숫자로 보여주며 경각심을 일깨웁니다.

기대 효과 요약 (ROI 설명):

월 15만 원의 투자로, 연봉 8,400만 원의 가치를 지키고, 최악의 상황에서도 가정이 유지될 수 있는 '안전장치'를 만드는 것임을 강조합니다.

26 VII. 컨설팅 시나리오 (Consulting Scenarios) (계속)

실행 플랜 요약 (Action Plan):

"가장 먼저 팀장님의 방패부터 튼튼하게 만들고, 그 다음에 다른 가족들의 갑옷을 점검해 드리는 순서로 진행하겠습니다."

고객이 자주 묻는 질문:

Q: "제 보험료 낼 돈으로 어머니 간병보험부터 해드리는 게 맞지 않을까요?" A: "물론 그 마음은 충분히 이해됩니다. 하지만 만약 팀장님이 먼저 아프시면, 어머니 간병보험료는 누가 내주시겠습니까? 팀장님의 소득이 안정적으로 유지되어야 어머니 보험도 끝까지 지켜드릴 수 있습니다. 뿌리가 튼튼해야 가지가 무성한 법입니다."

결론:

자신을 위한 투자가 곧 가족을 위한 최고의 투자임을 확신시키고 결단을 유도합니다.

27 VII. 컨설팅 시나리오 (Consulting Scenarios) (계속)

실무상담 스크립트

[상담 시작] "팀장님, 어머님 걱정애 자녀들 생각까지... 정말 어깨가 무거우시겠습니다. 그런데 제가 오늘 가장 먼저 여쭙보고 싶은 것은 '팀장님 자신'에 대한 이야기입니다. 혹시 팀장님이 한 달만 일을 쉬게 되면, 우리 가정은 괜찮을까요?"

[문제 인식] "데이터를 보면, 팀장님의 소득이 멈추는 순간 가계는 매달 500만 원씩 적자가 발생합니다. 1년이면 6천만 원이죠. 어머님 간병은 커녕, 아이들 학원부터 끊어야 할 상황이 올 수 있습니다. 이 위험을 이대로 두는 것은 너무 아슬아슬한 줄타기 같습니다."

[솔루션 제안] "그래서 제 첫 번째 제안은 다른 가족이 아닌 바로 팀장님을 위한 '소득 방어 플랜'입니다. 월 15만 원 정도로, 팀장님께 무슨 일이 생겨도 최소한의 소득이 보장되는 안전장치를 만드는 겁니다. 이것만 해두셔도 마음의 짐을 절반은 덜 수 있습니다."

[동의 유도] "어머님을 위하고 자녀를 위하는 그 마음, 저도 잘 압니다. 그렇기 때문에 팀장님부터 지켜야 한다고 말씀드리는 겁니다. 저와 함께 팀장님이라는 가장 소중한 자산부터 지키는 일, 지금 시작하시겠습니까?"

28 VII. 컨설팅 시나리오 (Consulting Scenarios) (계속)

심화 응대 스킬

[죄책감 전환 기법]

상황: "제가 먼저 보험을 하면 이기적인 것 같아서 마음이 불편해요"

응대법: "팀장님, 그 마음 너무 이해합니다. 하지만 잠깐, '이기적'이라는 단어를 다시 생각해볼까요? 항공기 안전수칙을 보면 '산소마스크가 떨어지면 본인이 먼저 착용한 후 다른 사람을 도와라'고 하잖아요. 이게 이기적인가요? 아니면 가장 현명한 방법인가요? 팀장님이 먼저 쓰러지면, 어머님도 자녀들도 모두 함께 위험해집니다. 반대로 팀장님이 든든하면, 모든 가족이 안전해져요. 진짜 이기적인 건 '나는 괜찮겠지'라며 위험을 방치해서 결국 가족 전체를 위기에 빠뜨리는 겁니다. 팀장님이 지금 하려는 선택은 이기적인 게 아니라 '가장 책임감 있는 가장의 결정'이에요."

[미래 시점 시뮬레이션 기법]

상황: "지금 당장은 건강한데 굳이 그럴 필요가 있을까요?"

응대법: "네, 지금은 정말 건강해 보이세요. 그런데 한 가지 실험을 해볼까요? 5년 후 팀장님을 상상해보세요. 그때 동료들이 이런 말을 합니다. '아, 나 5년 전에 보험 들어둔 게 정말 다행이야. 마음이 얼마나 편한지 몰라.' 이제 반대 상황을 상상해보세요. 5년 후 팀장님이 병원에서 진단을 받으셨어요. 그때 드는 첫 번째 생각이 '돈은 어떻게 하지'라면... 얼마나 절망적일까요? 보험은 '아플 때를 위한 준비'가 아니라 '건강할 때 마음의 평화를 사는 것'입니다. 5년 후 팀장님은 어떤 팀장님이 되고 싶으세요?"

29 VII. 컨설팅 시나리오 (Consulting Scenarios) (계속)

▶ 상담주제 2: 월 15만원으로 '간병 지옥'에서 탈출하기

리스크 진단 (As-Is 파악):

통계 자료를 활용하여, 장기 간병 기간 평균 5~10년, 월평균 비용 200~300만 원이라는 현실을 객관적으로 제시합니다. "이 비용을 10년간 모으려면 2~3억 원의 현금이 필요합니다."

전략 제안 (To-Be 플랜):

간병/치매 보험을 '비용'이 아닌 '리스크 관리 수단'으로 설명합니다. 매달 15만 원이라는 '정해진 금액'으로, 매달 수백만 원이 될지 모르는 '정해지지 않은 위험'을 통제하는 원리를 설명합니다.

기대 효과 요약 (ROI 설명):

30 VII. 컨설팅 시나리오 (Consulting Scenarios) (계속)

실행 플랜 요약 (Action Plan):

어머니의 현재 건강 상태를 고려하여 가입 가능한 상품 중 가장 유리한 플랜을 즉시 찾아 진행할 것을 제안합니다.

고객이 자주 묻는 질문:

Q: "어머니 연세가 많으셔서 보험료가 너무 비싸지 않나요? 그냥 적금 붓는 게 낫지 않을까요?" A: "좋은 질문입니다. 월 15만 원씩 10년을 저축해도 1,800만 원입니다. 이걸로는 1년치 간병비도 안됩니다. 보험은 '시간'을 사는 것입니다. 가입 다음 달에 당장 상황이 발생해도 약속된 돈을 받을 수 있는 유일한 금융상품입니다."

결론:

막연한 불안감을 안고 사는 대신, 구체적인 해결책을 통해 마음의 평화를 얻으시라고 설득합니다.

31 VII. 컨설팅 시나리오 (Consulting Scenarios) (계속)

☞ 실무상담 스크립트

[상담 시작] "팀장님, 어머님 간병 문제, 생각만 해도 막막하시죠? 앞으로 돈이 얼마나 들지, 언제까지 계속될지 아무도 모르니까요. 제가 오늘 그 '끝 모를 불안감'을 '매달 15만 원짜리 영수증'으로 바꿔드릴 방법을 가져왔습니다."

[문제 인식] "만약 내일 당장 어머님께 매달 200만 원씩 간병비가 들어간다면, 팀장님은 그 돈을 어디서 마련하시겠습니까? 아이들 교육 자금? 아니면 부부의 노후 자금? 어떤 것을 깨도 마음이 아픈, 힘든 선택을 해야만 합니다."

[솔루션 제안] "하지만 월 15만 원으로 어머님 간병보험을 준비해두시면, 그 힘든 선택을 할 필요가 없어집니다. 약관상 정한 요건(장기요양등급·CDR·지속기간 등) 충족 시 계약한 민영보험에서 월 100만 원 지급이 이루어집니다. 내 돈은 절반만 쓰면 되니, 팀장님의 삶과 자녀의 미래를 지킬 수 있습니다. 이것이 지혜로운 효도입니다."

[동의 유도] "막연한 걱정은 사람을 지치게 만듭니다. 이 솔루션은 어머님을 위한 것이기도 하지만, 결국 팀장님이 두 발 뻗고 주무실 수 있게 하는 '마음의 평화 보험'입니다. 제가 가장 좋은 조건으로 바로 진행해 드릴까요?"

32 VII. 컨설팅 시나리오 (Consulting Scenarios) (계속)

심화 응대 스킬

[경제적 임팩트 가시화 기법]

상황: "어머니 보험까지 제가 들어야 하나요? 부담스러워요"

응대법: "팀장님, 계산기를 한번 같이 꺼내볼까요? 월 15만원 × 12개월 = 180만원. 1년에 180만원이에요. 그런데 어머니가 장기요양 상태가 되시면 월 250만원 × 12개월 = 3,000만원. 1년에 3,000만원입니다. 180만원으로 3,000만원을 막는 거예요. 이게 부담스러우신가요, 아니면 3,000만원이 부담스러우신가요? 지금 팀장님은 '180만원을 어떻게 마련하지?'를 고민하고 계시는데, 제가 도와드리고 싶은 고민은 '3억원을 어떻게 막지?'입니다. 어떤 게 더 현실적인 해결책일까요?"

[타이밍 크리티컬 어필 기법]

상황: "좀 더 생각해보고 나중에 결정할게요"

응대법: "물론 신중하게 결정하셔야죠. 그런데 어머니 연세와 건강 상태를 생각해 보세요. 보험 가입 기회는 지금 이 순간 놓치면 다시 없을 수 있습니다. 이걸 마치 태풍 경보가 내렸는데 '태풍이 와봐야 창문을 막겠다'는 것과 같아요. 태풍이 오면 이미 늦어요. 심사라도 먼저 받아 보시는 건 어떠세요? 결과를 보고 최종 결정하셔도 늦지 않아요."

33 VII. 컨설팅 시나리오 (Consulting Scenarios) (계속)

▶ 상담주제 3: Plan B - 보험이 최선이 아닐 때를 위한 '재무 방어벽' 구축

리스크 진단 (As-Is 파악):

"심사 결과가 아쉽게도 좋지 않습니다. 이는 '어머니의 간병 리스크'를 보험으로 해결할 수 없으며, 이제 이 리스크는 팀장님 가정의 노후 자산과 직접적으로 연결되었다는 의미입니다."

전략 제안 (To-Be 플랜):

상황을 '실패'가 아닌 '전략적 전환'으로 재정의합니다. "보험이라는 방패를 쓸 수 없다면, 우리는 더 튼튼한 '성벽'을 직접 쌓아야 합니다. 어머니 보험료로 쓰려던 예산을 이제 팀장님 본인의 보장을 강화하고, 나머지는 '간병 자금 전용 계좌'로 시스템화하여 어떤 외부 요인에 도 흔들리지 않는 현금 흐름을 만들겠습니다."

기대 효과 요약 (ROI 설명):

월 20만 원의 강제 저축 시스템으로 5년 후 약 1,200만 원의 '1차 방어 자금'을 확보할 수 있음을 보여줍니다. "이것은 단순히 돈을 모으는 것이 아니라, 위기 시 가족이 무너지지 않고 버틸 수 있는 귀중한 '시간'과 '선택권'을 버는 것입니다."

34 VII. 컨설팅 시나리오 (Consulting Scenarios) (계속)

실행 플랜 요약 (Action Plan):

"가장 먼저 팀장님의 방패(본인 보장 강화)부터 완벽하게 만든 뒤, 바로 간병 자금 계좌를 만들어 자동이체를 설정하는 것까지 오늘 저와 함께 마무리하시죠."

고객이 자주 묻는 질문:

Q: "그렇게 모은 돈으로 실제 간병비를 다 감당할 수 있을까요?" A: "모든 비용을 대체하기는 어렵습니다. 하지만 이 자금은 갑작스러운 위기 시 예적금을 깨거나 대출을 받는 최악의 상황을 막아주는 '충격 흡수 장치'입니다. 아무 대비가 없는 것과는 하늘과 땅 차이의 결과를 만듭니다."

결론:

보험 가입 실패라는 상실감을, 스스로 통제 가능한 재무 계획을 세웠다는 '주도권'과 '안정감'으로 전환시켜 드립니다.

35 VII. 컨설팅 시나리오 (Consulting Scenarios) (계속)

실무상담 스크립트

[상황 전달] "팀장님, 심사 결과가 좋지 않게 나와서 많이 실망하셨을 것 같습니다. 저도 안타까운 마음입니다. 하지만 저는 사실 이런 상황을 미리 예상하고, 오히려 더 확실하고 주도적인 Plan B를 준비해 두었습니다."

[문제 재정의] "이제 우리는 '보험사가 받아주지 않는 리스크'를 다루는 게 아닙니다. '우리가 직접 통제하고 관리할 수 있는 미래 자금'을 만드는, 훨씬 더 능동적인 프로젝트를 시작하는 겁니다."

[솔루션 제안] "어머니 보험료로 생각했던 월 25만 원 중, 10만 원은 팀장님 본인의 보장을 완벽하게 만드는 데 쓰고, 나머지 15만 원은 지금 바로 '어머니 사랑 통장'을 만들어 매달 강제로 저축하는 시스템을 만들겠습니다. 이 돈은 그 어떤 위험에도 흔들리지 않는 팀장님 가족만의 비상금이 될 겁니다."

[동의 유도] "외부의 결정에 미래를 맡기는 대신, 이제 우리 손으로 직접 가족의 안전장치를 만드는 일입니다. 제가 끝까지 함께하겠습니다. 지금 바로 시작하시겠습니까?"

36 VII. 컨설팅 시나리오 (Consulting Scenarios) (계속)

심화 응대 스킬

[부정적 감정 전환 기법]

상황: "결국 가입도 안 될 거면서 괜히 시간만 낭비했네요."

응대법: "시간 낭비가 아닙니다, 팀장님. 이번 과정을 통해 우리는 '보험으로는 해결이 안 된다'는 매우 중요한 사실을 '확인'한 겁니다. 만약 이 확인 없이 막연히 괜찮을 거라 생각했다면, 나중에 정말 큰 낭패를 봤을 겁니다. 이제 우리는 불확실성을 제거하고, 가장 현실적인 최선의 길을 찾아낸 것입니다. 이것이야말로 진짜 시간과 돈을 번 것입니다."

[소유권 이전 기법]

상황: "결국 그냥 적금하라는 거잖아요..."

응대법: "단순한 적금과는 개념이 다릅니다. 일반 적금은 언제든 깎 수 있는 돈이지만, 이 계좌는 '어머니 간병'이라는 명확한 목적을 가진, 누구도 함부로 손댈 수 없는 우리 가족의 '재무 방어벽'입니다. 보험사 대신, 이제 팀장님께서 직접 이 방어벽의 주인이 되어 통제하고 키워나가는 겁니다. 훨씬 더 든든하지 않으신가요?"

37 VII. 컨설팅 시나리오 (Consulting Scenarios) (계속)

▶ 공통 상황별 추가 응대 스킬

[가치 우선순위 재정렬기법]

상황: "다른 급한 일이 많아서... 보험은 나중에 해도 될 것 같아요"

응대법: "팀장님, 급한 일과 중요한 일을 구분해볼까요? 급한 일은 마감이 있지만, 중요한 일(가족 건강, 위기 대비)은 마감 없이 계속 미루게 되죠. 정말 무서운 건, 중요한 일을 미루다가 갑자기 '가장 급한 일'로 바뀌는 순간이에요. 지금 우리가 하는 일은 '중요한 일이 급한 일로 바뀌는 걸 막는 것'입니다. 급한 일에 치여서 정작 중요한 걸 놓치고 싶지는 않으시죠?"

[감정적 미래 투영 기법]

상황: "솔직히 보험 얘기만 들으면 우울해져요. 안 좋은 일만 생각하게 되고..."

응대법: "그 마음 정말 이해해요. 그런데 관점을 바꿔보면 어떨까요? 지금 우리가 하는 이야기는 '안 좋은 일이 일어날 거야'가 아니라 '안 좋은 일이 일어나도 괜찮을 거야'입니다. 완전히 다른 이야기예요. 10년 후 '그때 보험 정말 잘 들어줬어, 마음이 얼마나 편한지 몰라.'라고 말하는 미래의 팀장님을 만들어드리고 싶어요. 불안감 때문에 상담하는 게 아니라, 안심하고 살기 위해 상담하는 거예요."

1. 전문용어 설명

장기요양등급

국민건강보험공단이 심신 기능 상태에 따라 1등급(최중증)부터 5등급 및 인지지원등급까지 판정합니다. 인정 유효기간 및 재판정(갱신) 주기는 개인의 상태·등급 등에 따라 공단이 정하며, 신청·심사 절차는 공단 지침을 따릅니다.

CDR 척도 (Clinical Dementia Rating Scale)

치매의 중증도를 평가하는 국제 표준 검사입니다. 6개 세부 영역 점수를 종합하여 Global CDR 점수 0, 0.5, 1, 2, 3점으로 최종 판정합니다. 보험에서는 통상 CDR 1~2점을 경증/중등도, CDR 3을 중증치매의 기준으로 활용하며 상품마다 보장 범위와 지급 조건이 다릅니다.

소득보상보험 (Disability Income Insurance)

질병이나 상해로 인해 경제활동이 불가능해질 경우(약관상 후유장해 지급률 기준 충족 등), 일정 기간 동안 매월 약속된 금액을 지급하여 소득을 보전해주는 보험입니다.

2. FAQ

Q1. 어머니가 이미 초기 치매 진단을 받으셨는데, 보험 가입이 가능한가요?

A1. 매우 어렵거나 불가능할 수 있습니다. 하지만 '초기' 진단이고 아직 경증이라면, 일부 유병자 간편심사 치매보험 등에서 부담보나 할증 조건으로 인수를 검토할 수 있습니다. 즉시 심사를 통해 가입 가능한 상품이 있는지 확인해봐야 합니다. 시간이 지체될수록 가입은 더 어려워집니다.

Q2. 제가(딸) 어머니 보험료를 내주면 증여세 문제가 생기지 않나요?

A2. 보험금 수령인과 보험료 납부자가 다른 경우 해당 보험금 상당액이 증여의제 대상입니다(상증세법 제34조). 본 설계(계약자=수익자 동일 구조)는 제34조 증여의제 회피에 일반적으로 유리하나, 보험료 자금 출처가 모친 등인 경우 실질과세 원칙상 이슈가 생길 수 있어 증빙 관리와 전문가 상담이 필요합니다.

Q3. 국민연금에 장애연금이 있는데, 별도로 소득보상보험이 필요한가요?

A3. 네, 필요합니다. 국민연금 장애연금은 장애의 원인이 된 질병/부상의 초진일로부터 1년 6개월이 지난 날(완치 시 완치일)을 장애결정 기준으로 삼아 그 이후 심사를 통해 지급 여부를 결정하므로, 소득 공백 발생 시점과 시차가 있습니다. 또한 지급 조건이 까다롭고 지급액이 충분하지 않을 수 있어, 민영 소득보상보험은 이러한 공적 제도의 틈을 메우는 중요한 역할을 합니다.

Q4. 보험금을 받지 못하는 경우도 있나요?

A4. 네, 다음과 같은 경우 보험금 지급이 제한될 수 있습니다: ①면책기간(통상 90일~2년) 내 발생한 사유, ②고의, 자해 등 약관상 면책사유, ③약관에서 정한 진단 기준 미충족, ④기왕증 관련 부담보 조건 등입니다. 따라서 가입 전 약관을 충분히 검토해야 합니다.

Q5. 보험료 납입이 어려워지면 어떻게 하나요?

A5. 자동대출 기능 활용, 보장 내용 조정을 통한 보험료 감액, 납입면제 특약 해당 여부 확인 등을 고려할 수 있습니다. 단, 이러한 변경은 보장 내용에 영향을 줄 수 있으므로 신중한 검토가 필요합니다.

3. 관련 법규·출처 (2025.09 기준)

상속세 및 증여세법 제34조 (보험금의 증여)

- ① 생명보험이나 손해보험에서 보험사고가 발생한 경우 그 보험금 수령인과 보험료 납부자가 다른 경우에는 ... 보험료 납부자가 수령인에게 보험금을 증여한 것으로 본다.

[실무 적용] 본 보고서에서 제안한 '계약자=수익자=딸' 구조가 세무 리스크를 회피하는 핵심 근거임을 설명합니다. 단, 아래 체크리스트처럼 자금 출처 관리를 명확히 해야 실질과세 원칙에 따라 안전하게 대응할 수 있습니다. [세무 안전 실무 가이드] 증빙 관리: 딸 명의 통장에서 보험료 자동이체, 어머니로부터 보험료 명목의 현금/이체 수령 금지, 연말정산 시 딸이 직접 세액공제 신청. 세무조사 대비 Q&A: "Q: 딸이 어머니 보험료를 내주는 게 증여 아닌가요?" → "A: 계약자와 수익자가 딸로 동일하여 보험금은 증여에 해당하지 않습니다. 다만, 보험료의 원천이 어머니 계좌로 밝혀지면 문제 소지가 있으므로, 반드시 딸의 소득 내에서 납부해야 합니다."

상법 제731조 (타인의 생명의 보험)

- ① 타인의 사망을 보험사고로 하는 보험계약에는 보험계약 체결 시에 그 타인의 서면(書面)에 의한 동의를 받아야 한다.

[실무 적용] 사망을 담보하는 특약(예: 질병사망)을 추가할 경우, 피보험자인 어머니의 서면동의를 필수 절차(미충족 시 계약 무효)임을 사전에 명확히 안내하고 실행 계획에 포함시켜야 합니다.

노인장기요양보험법

제40조(본인부담금) ① ... 재가급여 ... 비용의 100분의 15를, 시설급여 ... 비용의 100분의 20을 ... 본인이 부담한다.

[실무 적용] 민영보험 약관이 참조하는 공적 제도의 근거입니다. 고객에게 간병비 시뮬레이션 시 본인부담률(재가 15%, 시설 20%)과 비급여 항목은 별도임을 안내하는 데 활용합니다.

국민연금법 시행령 제48조

① ... 장애 정도의 결정은 장애의 원인이 되는 질병이나 부상의 초진일(初診日)부터 1년 6개월이 지난 날 ... 을 기준으로 한다.

[실무 적용] 국민연금 장애연금은 소득 상실 시점으로부터 1년 6개월이라는 긴 시간이 지나야 수령 여부가 결정됩니다. 이 공백 기간을 메우기 위해 민영 소득보상보험이 필수적이라는 점을 설명하는 핵심 근거로 사용합니다.

4. 언더라이팅 & 약관 점검 체크리스트

체크리스트

- 계약 구조: 계약자·수익자를 '딸'로 동일하게 설정하여 증여세 이슈 최소화.
- 자금 출처: 보험료는 반드시 '딸' 명의의 계좌에서 자동이체.
- 피보험자 동의: 사망 관련 특약 추가 시 '어머니'의 서면 동의서 확보.
- 치매/LTC 약관: 지급 조건이 'CDR 점수' 기준인지 '장기요양등급' 기준인지 명확히 비교 설명.
- 면책/감액 기간: 가입 후 90일 또는 1~2년 등 보험금이 지급되지 않거나 50%만 지급되는 기간을 반드시 안내.
- 소득보상(DI) 약관: 지급 조건이 '후유장해율'인지 '근로불능상태'인지 확인하고 고객의 직업에 더 유리한 상품을 선택.

5. 보험금 청구 준비 체크리스트 (LTC/치매 & DI)

목적: 청구 반려·지연을 최소화하기 위한 “사전 서류·타임라인·주의사항” 표준 세트 (클릭하여 확인하세요.)

A. 공통 원칙 (모든 담보 공통)

- 보험금 청구서, 개인정보처리동의서, 신분증 사본 등 기본 서류 준비
- 진단서, 입퇴원확인서 등 모든 서류는 최근 3개월 내 발급된 원본 제출 원칙 (사본 제출 시 원본대조필/발급기관 확인 필수)
- 서류 간 진단명, 질병코드, 날짜 등이 일치하는지 교차 확인
- 발생일자 타임라인 정리 (초진일→입원/수술→등급/판정→치료경과)

B. 간병/치매(LTC) 청구 준비

핵심 요건 확인

- 약관상 요건: 장기요양등급(1~5 또는 인지지원), CDR 기준, 상태 지속기간(예: 90일), 보장개시/감액기간 등 상품별 상이
- 지급 형태: 월지급/일시금 구분 및 중복 담보 유무

필수 서류

- 피보험자 신분증 사본, 통장 사본(수익자 일치)
- 장기요양 인정서(등급표기), 등급판정 결과통보서/방문조사서 요약
- 의사 진단서(치매 진단 시 CDR 포함) 및 CDR 평가지(가능한 경우)
- 치료·투약내역, 입·퇴원확인서/진료비 영수증(비급여 포함)
- 보험사 청구서(개인정보 동의 포함), 위임장(대리 청구 시)

🔥 자주 나는 반려 사유 & 예방 팁

- 반려: “장기요양 등급 근거 서류 누락/CDR 점수 미기재/상태 지속기간 증빙 부족”
- 예방: 결과통보서·CDR 평가지 원본 발급 요청, 재평가/경과기록 첨부

📅 타임라인 권장

- 등급 인정 즉시 서면 결과 수령 → 약관 요건 매칭표 작성 → 7일 내 접수

C. 소득보상(DI) 청구 준비

핵심 요건 확인

- 지급 트리거: 후유장애율 또는 근로불능 기준(상품별 상이)
- 주요 체크사항: 대기기간(30/60/90일), 지급기간(예: 10년), 재심사 주기(6~12개월), 직업등급 영향 확인

필수 서류

- 피보험자 신분증 사본, 통장 사본(수익자)
- 의사 소견서/진단서(장해 정도·업무/일상생활 제한 명시)
- 입·퇴원 확인서, 수술기록/재활기록, 치료 계획서
- 소득 증빙(근로소득원천징수 등), 직무기술서(업무 내용·필수 업무능력 명시)
- 회사 병가·휴직 증명(근로자), 사업자 운영 중단 증빙(자영업)
- 보험사 청구서, 개인정보 동의, 위임장(필요 시)

 자주 나는 반려 사유 & 예방 팁

- 반려: “직무와 장애의 인과관계 불명확, 대기기간 미충족, 치료 경과 부족”
- 예방: 직무기술서+의사 소견서에 “업무 수행 불가 사항”을 일치된 표현으로 기재

 타임라인 권장

- 대기기간 충족 예상 2주 전부터 서류 수집 시작 → 충족일 다음날 접수
- 재심사 캘린더(6~12개월) 미리 등록, 경과 기록 지속 추적

D. 제출 전 최종 점검 (Quick Check 6)

- 약관 요건(트리거·대기·지속·개시·감액) 매칭표 완성
- 초진일/진단일/등급일/지급개시일 타임라인 정합성
- 진단명·코드·CDR 점수 서류 간 동일
- 소득·직무 관련 인과관계 서술 일치

- 통장·수익자·계약자 일치 여부
- 원본/사본 구분 및 원본대조필 완료

메모: 접수 후 3영업일 내 접수 확인 콜/문자를 받고, 보완 요청 시 당일 회신 원칙. 모든 커뮤니케이션은 날짜·담당자·요청사항을 기록해 청구 로 그로 보관.

6. 간병비 현실·계산 가이드

A. 비용 구분

공적 급여

요양시설 입소 시 발생하는 수가의 본인부담금(통상 20%) + 비급여 항목.

사설 비용

사설 간병인, 재가 서비스 등은 지역과 서비스 수준에 따라 편차가 크므로 월 200~350만 원 등 범위로 설정하여 참고치로 안내.

B. 상담용 계산법

월 예상 부담액 =

[사설·비급여 비용] + [공적 본인부담금] - [민영보험 월 지급액]

초기 필요 목돈 =

[입소 보증금 등] - [민영보험 일시 지급액]

컨설턴트 주의사항

본 보고서에 제시된 보험료, 보장 내용, 효과 분석 등은 가상의 사례를 기반으로 한 시뮬레이션입니다. 실제 계약 시에는 개별 고객의 조건과 보험사 심사, 제도 변화 등에 따라 모든 내용이 달라질 수 있습니다. 따라서 실제 상담 시에는 반드시 최신 약관과 상품설명서를 기준으로 정확한 내용을 안내하시기 바랍니다.

보고서 안내

본 보고서는 일반적인 사례를 바탕으로 한 교육용 시뮬레이션이며, 2025년 9월 23일 현재 정보를 기준으로 합니다. 개인의 특수한 상황이나 향후 법령 변경 사항은 반영되지 않았습니다. 모든 전략의 실행 전에는 반드시 세무사, 변호사, 회계사 등 관련 전문가의 구체적인 검토와 자문을 받으시기 바라며, 실행 결과에 대한 책임은 전적으로 의사결정권자에게 있습니다.